

Fluxo de Encaminhamento de Crianças para atendimento com Médico Pediatra

Este fluxo tem a finalidade de garantir o cuidado integral às crianças e adolescentes, especialmente as com maior probabilidade de adoecer e morrer. Para tal, é necessária a estratificação de risco das crianças atendidas pela Atenção Primária à Saúde (APS) - enquanto ordenadora e coordenadora do cuidado na Rede de Atenção à Saúde (RAS). A identificação do risco do Recém-Nascido (RN) pode acontecer ainda na maternidade, porém os critérios devem ser reavaliados de forma contínua e dinâmica durante o acompanhamento da criança nas consultas e visitas domiciliares da APS.

É importante enfatizar que o acompanhamento de todas as crianças deve ser realizado pela APS, de forma exclusiva ou compartilhada para aquelas consideradas de risco ou com necessidades que justifiquem o atendimento especializado. A continuidade do cuidado deve ser garantida à criança e sua família. Assim, as equipes de APS e atenção especializada (AE) devem atuar como uma única equipe, devendo manter objetivos e condutas comuns com relação aos critérios de manejo recomendados por diretrizes clínicas e Ministério da Saúde. Lembrando que o principal canal de comunicação entre as equipes é o Prontuário Eletrônico do Paciente, devendo este ser preenchido de forma clara e completa a fim de garantir a gestão compartilhada do cuidado da criança, sendo a APS a ordenadora desse cuidado.

Estratificação de Risco (em todas as consultas)

Risco Habitual (RH)

Crianças com características individuais e sociodemográficas favoráveis.

- Nascidas a termo – Idade gestacional ≥ 37 e < 42 semanas;
- Peso ao nascer $\geq 2500g$ e $< 4000g$;
- Apgar de 5º minutos ≥ 7 ;
- Triagens neonatais com resultados normais (Testes do Olhinho, Orelhinha, Linguinha, Coraçãozinho, Ortolani e Pezinho);
- Crescimento e desenvolvimento adequados de acordo com gráficos e marcos dispostos na caderneta da criança;
- Vacinação em dia.

Risco Intermediário (RI) - 2 ou mais fatores

Filhos de Mães:

- Com infecções durante a gestação (Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes vírus, Zika vírus e/ou HIV);
- Em situação de vulnerabilidade (situação de rua, indígenas, quilombolas ou migrantes);
- Com menos de 4 consultas de pré-natal;
- Idade < 18 e > 40 anos;
- Com menos de 20 anos e mais de 3 partos;
- Analfabetas ou com menos de 4 anos de estudo;

- Que apresentaram exantema durante a gestação;
- Com gravidez indesejada ou de difícil aceitação;
- Com 3 ou mais abortos espontâneos, ou com óbito fetal em gestação anterior
- Com óbito de filho menor de 5 anos por causa evitável;
- Com histórico de violência interpessoal;
- Com gravidez decorrente de violência sexual;
- Sem suporte familiar (sem rede de apoio para compartilhar o cuidado com a criança);
- Sem fonte de renda familiar;
- Com depressão pós-parto (diagnóstico atual ou pregresso);
- Ausente por doença, abandono ou óbito;
- Mãe e/ou pai privados de liberdade.

Características da criança:

- Peso ao nascer $\geq 2000\text{g}$ e $< 2500\text{g}$;
- Idade gestacional ≥ 35 e < 37 semanas;
- Anomalias congênitas menores (relativamente frequentes nas população geral e que não acarretam maiores problemas aos portadores. Ex: fossetas, apêndices pré-auriculares, polidactilias do tipo de apêndices digitiformes, hipospadias de 1º grau ou balcônicas, mamas extranumerárias, nevos pigmentados).
- Um dos pais/cuidadores com transtorno mental severo, deficiência física e/ou doença neurológica;
- Pais/cuidadores com dependência de álcool e/ou outras drogas.
- Com cuidador que apresenta indícios de violação dos direitos da criança;
- Sem acesso a saneamento básico e/ou água potável;
- Sem a realização de triagem neonatal;
- Desmame precoce (antes dos 6 meses de vida);
- Desnutrição ou curva pondero estatural estacionária ou em declínio (de acordo com gráficos da caderneta da criança) e ou carências nutricionais;
- Sobrepeso (de acordo com gráficos da caderneta da criança);
- Com esquema vacinal em atraso ou não vacinada (inclusive as com contraindicação ao imunizante);
- Com presença de cárie;
- Com 3 ou mais atendimentos em pronto atendimento em um período de 3 meses.

Alto Risco (AR) - pelo menos um fator

- Peso ao nascer $< 2000\text{g}$ ou $\geq 4000\text{g}$;
- Idade gestacional ≤ 34 semanas;
- Asfixia perinatal e/ou Apgar de 5º minutos ≤ 6 ;
- Afecções perinatais (Eventos ocorridos no período perinatal que afetam a saúde do feto ou da criança, podendo causar sua morte (grupo de causas básicas de óbito relacionado com o período perinatal pela classificação CID-10 - grupo P00-P96)
- Hiperbilirrubinemia com exsanguineotransfusão;
- RN com perímetro cefálico (PC) inferior ao esperado para a idade e sexo (microcefalia) ou criança com crescimento inadequado do (PC) e/ou alterações

neurológicas do Sistema Nervoso Central: dependendo de sua etiologia, esta pode ser associada a malformações estruturais do cérebro, com repercussões no desenvolvimento.

- Malformações congênitas graves, com repercussões clínicas (graves alterações anatômicas, estéticas e funcionais, podendo levar à morte. Ex: lábio leporino com ou sem palato fendido, sindactilias, microtia, cardiopatias congênitas, etc;
- Doenças genéticas, cromossomopatias ou doenças metabólicas com repercussão clínica (Ex: Síndrome de Down, Síndrome de Patau, entre outras;
- Infecções crônicas por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes vírus, Zika vírus e/ou HIV, confirmadas ou em investigação;
- Internação ou intercorrência na maternidade ou em unidade neonatal, ao nascer;
- Testes de triagem neonatal alterados (pelo menos um);
- Desenvolvimento psicomotor insatisfatório para a faixa etária (de acordo com os marcos do desenvolvimento da caderneta da criança);
- Sinais de violência e/ou maus tratos;
- Desnutrição grave ou obesidade;
- Intercorrências repetidas com repercussão clínica;
- Três ou mais internações nos últimos 12 meses.

Observações:

- 1- A estratificação de risco deve ser realizada em todas as consultas, sejam médicas ou de enfermagem;
- 2- A emissão da Ficha de Notificação de Criança de Risco pela 4ª Coordenadoria de Saúde, classifica o RN como de risco (intermediário ou alto), mas a APS deve realizar a estratificação a cada consulta a fim de verificar a permanência ou não dos fatores de risco;
- 3- A identificação de um único critério define o estrato de risco da criança, predominando o critério maior;
- 4- Quando a equipe especializada (pediatra) resolver dar alta da criança do setor, deve obrigatoriamente, emitir contra referência para APS;
- 5- Crianças consideradas como de Risco Habitual deverão ser acompanhadas pela APS conforme recomendação do Ministério da Saúde (ver tabela 1);
- 6- Para crianças classificadas como de Risco Intermediário, o calendário de consultas deve ser ampliado (ver tabela 1) e o acompanhamento intensificado. Caso evoluam sem melhora ou com piora dos fatores de risco, devem ser encaminhadas ao especialista;
- 7- Crianças consideradas como de Alto Risco devem ter o cuidado na APS ainda mais intensificado e compartilhado com a AE, sendo a APS a ordenadora do cuidado e quem deve monitorar o seguimento (ver tabelas 1 e 2). Lembrando que o acompanhamento especializado pode acontecer no setor terciário (Ex: HUSM);
- 8- Do 3º ao 9º ano de vida, as consultas passam a ser anuais, próximas ao mês de aniversário para as crianças de risco habitual e semestrais para as de médio e alto risco;
- 9- A APS poderá encaminhar crianças consideradas de Risco Habitual para o especialista para avaliação e/ou conduta específica em caso de necessidade, devendo a AE contrarreferenciar a criança para a APS após resolução do motivo

do encaminhamento.

Tabela 1 – Calendário de Consultas de Puericultura na APS

Risco	1ª sem	1º m	2º m	3º m	4º m	5º m	6º m	7º m	8º m	9º m	10º m	11º m	12º m	15º m	18º m	21º m	24º m
RH	X	X	X		X		X			X			X		X		X
RI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
AR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabela 2 – Calendário de Consultas de Puericultura na Atenção Especializada

Estratificação de Risco	Número de atendimentos na AE
Alto Risco	4 atendimentos no 1º ano de vida 1 atendimento entre 15 e 18 meses 1 atendimento aos 24 meses de vida

Exemplos de condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento ao Pediatra:

- Alterações no Crescimento e Desenvolvimento;
- Asma de difícil manejo e outras pneumopatias;
- Cardiopatias;
- Nefropatias;
- Diabetes;
- Problemas neurológicos (Epilepsia, atraso da linguagem, paralisia cerebral, fechamento precoce da fontanela anterior, Suspeita de transtorno do Espectro Autista, Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, micro ou macrocefalia, etc);
- Hipertensão;
- Pós internações hospitalares.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Diário Oficial da União, 08 mar 2016.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13

de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,

Brasília, DF, 16 jul. 1990. Seção 1, p. 13563.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de quadros de procedimentos: Aidpi Criança: 2 meses a 5 anos / Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.130, de 05 de agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Manual AIDPI Neonatal: quadro de procedimentos / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas; Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

PARANÁ. Secretaria de Saúde. Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde. Estratificação de Risco de Crianças no Paraná. Curitiba, 2021. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/Estratifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20risco%20e%20acompanhamento%20de%20puericultura%20aprovada%20em%20CIB%2028.04.2021.pdf>. Acesso em: 09 dez, 2022.

CONTAGEM. Prefeitura Municipal de Contagem. Secretaria Municipal de Saúde. Manual de Acompanhamento e Referenciamento da Criança - Atenção Primária de Contagem. Contagem, 2019. Disponível em: <<https://www.contagem.mg.gov.br/sms/wp-content/uploads/2020/08/Manual-de-Acompanh>

[amento-e-Referenciamento-da-Crian%C3%A7a-na-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1si-ca-2%C2%AAedi%C3%A7%C3%A3o-13-11-19.pdf](#)>. Acesso em 09 dez, 2022.

COREN RS. Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária em Saúde: Saúde da Criança e do Adolescente. Porto Alegre, 2020. Disponível em: <<https://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/ProtocolosEnfermagem/ProtocoloEnfermagemSaudeCriancaAdolescente042022.pdf>> Acesso em 26 dez, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Síntese de evidências para políticas de saúde : mortalidade perinatal. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sintese_evidencias_mortalidade_perinatal.pdf> Acesso em 26 dez, 2022.